

Baptiste Coustet

Sémiologie médicale

L'apprentissage pratique
de l'examen clinique

6^e édition



Déjà
40 000
exemplaires
vendus

Nouvelle édition
tout en couleur
+ l'appli offerte

Vuibert

Baptiste Coustet

Sémiologie médicale

**L'apprentissage pratique
de l'examen clinique**

6^e édition

Vuibert

Maquette intérieure : CB Defretin
Adaptation de la maquette et mises en pages : SCM
Couverture : Primo & Primo

Illustrations :

© A.C.R. : Anne-Christel Rolling
© S.M. : Sandrine Marchand
© Photos : Baptiste Coustet

ISBN : 978-2-311-66089-0

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1^{er} de l'article 40). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© Juillet 2019, Éditions Vuibert – 5, allée de la 2^e DB – 75015 Paris
Site internet : www.vuibert.fr

L'auteur

Baptiste Coustet est médecin spécialiste et passionné de sémiologie, qu'il a pu enseigner et transmettre comme chef de clinique des hôpitaux de Paris, conférencier des épreuves classantes, auteur de cas cliniques et quotidiennement auprès des malades.

Collège des relecteurs

Remerciements chaleureux aux relecteurs spécialistes, par ordre alphabétique :

Docteur Elie AZRIA, PHU de Gynécologie-Obstétrique, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Marie-Germaine BOUSSER, ancienne Chef de service de Neurologie, CHU Lariboisière

Professeur Enrique CASALINO, Chef de service des Urgences, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Bruno CRESTANI, PUPH de Pneumologie, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Béatrice CRICKX, ancienne Chef de service de Dermatologie, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Michel LEJOYEUX, Chef de service de Psychiatrie, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Jean-Marie LE PARC, ancien Chef de service de Rhumatologie, CHU Ambroise Paré

Professeur Dominique LUTON, Chef de service de Gynécologie-Obstétrique, CHU Bichat-Claude Bernard

Docteur Maxime PALAZZO, PH Gastro-entéro-pancréatologie, CHU Beaujon

Professeur Vincent RAVERY, Chef de service d'Urologie, CHU Bichat-Claude Bernard

Professeur Ronan ROUSSEL, PUPH d'Endocrinologie-Nutrition, CHU Bichat-Claude Bernard

Remerciements

Lisa, merci pour ta présence bienveillante. À Margaux et Sophie.

À ceux qui m'ont transmis leur passion :

Pr Valla, Pr Marcellin, Pr Ruszniewski, Pr Levy,

Pr Bardin, Pr Dieudé, Pr Le Parc, Pr Lioté, Pr Meyer, Pr Orcel, Pr Richette,
Pr Ottaviani

Dr De Lecluse, Dr Frey, Dr Le Van, Dr Lhuissier, Dr Montalvan, Pr Richalet,
Dr Rodineau, Pr Thoreux,

Dr Graveleau, Dr Bourdain, Dr Wang,

Pr Levesque, Dr Baccar,

Pr Casalino, Dr Roussel,

Pr Crickx, Pr Descamps,

Pr Barry, Dr Albert, Pr Vacher,

Dr Benayoun, Pr Mal,

Pr Sereni,

Pr Bourillon, Pr Bousser, Pr Yelnik,

Pr Vahanian.

Aux photographiés.

Avant-propos

*« J'essaie de faire ce que je ne sais pas faire,
c'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. »*

Pablo Picasso

Examiner un malade ! Voici quelque chose de bien banal après quelques années à répéter, perfectionner son interrogatoire et ses gestes. Et pourtant, on ne peut oublier la première fois ; celle où l'on se lance avec peu ou pas de certitude, avec ce sentiment de privilège, de fierté et, en même temps, l'angoisse liée à la somme des connaissances à acquérir et cette conviction croissante, telle une épée de Damoclès, que l'oubli et l'erreur nous guettent...

Passionnant ! La diversité et les subtilités de l'examen clinique, le caractère unique de chaque malade rendent cet apprentissage exigeant mais ô combien enrichissant. La curiosité et la volonté de toujours comprendre seront vos fidèles alliés dans ce but élevé de devenir un bon médecin, humain, de pratiquer une médecine qui s'intéresse au malade dans sa globalité.

Savoir s'étonner ! C'est aussi un moteur pour ne pas tomber dans la facilité d'un examen stéréotypé sans signification et passer à côté des subtilités qui sont le moteur de votre apprentissage et des découvertes.

L'examen clinique est ce qui fait de la médecine un art. Il évolue sans cesse, se basant sur des signes parfois millénaires, se délestant du non contributif. C'est la raison d'être de cet ouvrage, au plus près de votre pratique, dans la poche de votre blouse.

J'ai voulu y présenter une sémiologie hiérarchisée, actuelle, adaptée à la pratique et rationnelle en facilitant la compréhension des choses tout en mettant en avant les signes décisifs, ceux qui apportent une information pertinente.

Cette sixième édition introduit la couleur et conserve son application smartphone pensée pour vous permettre de rechercher rapidement au lit du malade les informations pratiques, mais aussi parcourir l'essentiel de la sémiologie médicale.

J'espère que ce guide répondra à vos attentes et vous donnera envie de pratiquer un examen clinique de qualité et raisonné.

Et n'hésitez pas, soyez curieux tout en demeurant patient à votre tour. C'est un apprentissage long mais tellement utile.

Baptiste Coustet

Comment utiliser cet ouvrage ?

Ce guide s'utilise de manière graduelle. Les premières lectures attentives vous permettront de comprendre, d'appréhender le vocabulaire médical et de saisir les raisonnements importants. De bonnes connaissances d'anatomie sont essentielles.

Il est recommandé de lire au préalable **les deux premiers chapitres de conseils méthodologiques et d'observation médicale**. Les abréviations, fréquemment utilisées dans la pratique et dans ce guide, sont listées en début d'ouvrage.

Chaque appareil peut être ensuite étudié progressivement, dans l'ordre qui vous conviendra.

Les chapitres regroupent tous les signes fonctionnels à rechercher à l'interrogatoire pour chaque appareil. Ils détaillent ensuite ce qu'il vous est nécessaire de connaître pour un examen clinique complet. Les informations sont hiérarchisées, les éléments les plus importants étant en caractères gras. **La sémiologie biologique** est détaillée par la suite, complétée en fin d'ouvrage par des tableaux regroupant l'ensemble des normales de laboratoires les plus utiles.

Les principes de base en radiologie sont abordés au chapitre 22. Pour approfondir, reportez-vous à l'ouvrage de Constance de Margerie, *Imagerie médicale pratique* (Éditions Vuibert, 2019).

Des moyens mnémotechniques **surlignés** ont été insérés pour faciliter votre apprentissage.

Les informations moins essentielles, à lire en deuxième lecture ont été marquées d'un filigrane en pointillé et écrites en plus petit.

Le chapitre 23, « Check-list », vous aidera à ne rien oublier, à être systématique et rigoureux. Habituez-vous à l'utiliser dès le début, même au lit du malade.

Enfin, **un index**, en fin d'ouvrage, vous permettra de trouver facilement les informations que vous cherchez ; il précise l'étymologie des mots que vous aurez à acquérir.

Utilisation de l'application smartphone

L'application smartphone vous permet de rechercher en texte et en image les éléments principaux de l'examen clinique.

Ainsi, vous y trouverez les définitions des termes médicaux, les éléments importants de l'interrogatoire devant un symptôme donné, les signes d'examen physiques à rechercher et comment examiner, au lit du patient.

Vous pourrez accéder au texte et à l'iconographie par moteur de recherche ou par les différentes parties de l'examen clinique, appareil par appareil.

Des éléments d'examen complémentaires ou de syndromes pathologiques courants sont inclus pour la plupart des appareils étudiés.



Table des matières

Liste des abréviations pour la sémiologie clinique par appareils	XIX
---	-----

Listes des abréviations pour la sémiologie biologique et radiologique	XXII
--	------

Partie 1 – Méthodologie

1. Conseils méthodologiques	3
1. Définitions	3
2. Méthode d'apprentissage de la sémiologie	6
3. Valeur des tests en médecine	7
2. Observation médicale	9
1. Introduction	9
2. Intérêt de l'examen clinique	9
3. Écriture de l'observation médicale	10
4. Plan de l'observation médicale	11
5. Conclusion	11
6. L'observation médicale en pratique	12
6.1. Interrogatoire général ou systématique	12
6.2. Interrogatoire orienté	18
6.3. Examen physique	18
6.4. Examens complémentaires déjà réalisés	19
6.5. Conclusion	19
7. Suivi du patient au cours de l'hospitalisation : évolution	21
3. La douleur, maître symptôme	30
1. Généralités	30
2. Physiopathologie	30
3. Caractéristiques d'une douleur	31
4. Évaluation de l'intensité	32
5. Traitement	33
5.1. Douleurs nociceptives	33
5.2. Douleurs neuropathiques	34
4. État général, fièvre et hydratation	36
1. Signes généraux (SG)	36
2. Fièvre	37
2.1. Définitions et physiopathologie	37
2.2. Diagnostic	37

2.3. Conduite à tenir	37
2.4. Caractéristiques de la fièvre	38
2.5. Cadres étiologiques de fièvre aiguë	39
2.6. Surveillance de la fièvre	39
3. État d'hydratation	40
3.1. Anamnèse	40
3.2. Signes physiques	40
3.3. Tableaux cliniques	41

Partie 2 – Sémiologie clinique par appareils

5. Examen cardiovasculaire	45
1. Examen cardiaque	45
1.1. Signes fonctionnels	45
1.2. Examen physique cardiaque	54
1.3. Tableau clinique cardiologique fréquent : insuffisance cardiaque	69
2. Examen vasculaire	74
2.1. Examen artériel	74
2.2. Artères en général	74
2.3. Artères carotides : signes neurologiques	75
2.4. Artères des membres	75
2.5. Aorte	76
2.6. Artères rénales	76
2.7. Examen physique	76
2.8. Tableaux pathologiques fréquents	82
2.9. Examen veineux	86
2.10. Examen lymphatique : lymphœdème	91
6. Examen pneumologique	92
1. Signes fonctionnels	92
1.1. Douleur thoracique	92
1.2. Dyspnée	93
1.3. Expectorations et bronchite chronique	95
1.4. Hémoptysie	96
1.5. Toux	97
1.6. Hoquet	98
1.7. Ronflement	98
2. Signes physiques	99
2.1. Inspection	99
2.2. Palpation : recherche des vibrations vocales (VV)	104
2.3. Percussion pulmonaire	105
2.4. Auscultation pulmonaire	106
3. Épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)	113
3.1. Paramètres principaux mesurés	113
3.2. Syndromes pathologiques	115
4. Ponction pleurale diagnostique	116
4.1. Technique	116
4.2. Paramètres mesurés et orientation	117
4.3. Grandes orientations étiologiques	117

5. Tableaux pathologiques fréquents	119
5.1. Infection respiratoire basse ou pneumopathie infectieuse ou pneumonie aiguë.....	119
5.2. Embolie pulmonaire (EP).....	120
5.3. Épanchement pleural liquidien	122
5.4. Pneumothorax (PNO) ou épanchement pleural gazeux.....	123
5.5. Asthme	124
5.6. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).....	127
5.7. Insuffisance respiratoire chronique.....	129
7. Examen de l'appareil digestif.....	130
1. Signes fonctionnels.....	130
1.1. Douleur abdominale.....	130
1.2. Troubles du transit.....	137
1.3. Hémorragie digestive (HD).....	141
1.4. Symptômes œsophagiens.....	143
2. Signes physiques	144
2.1. Inspection.....	144
2.2. Palpation abdominale.....	147
2.3. Percussion abdominale.....	155
2.4. Auscultation abdominale.....	156
2.5. Toucher rectal.....	157
3. Regroupements syndromiques.....	159
3.1. Urgences chirurgicales extrêmes.....	159
3.2. Urgences chirurgicales	160
3.3. Urgence médicale : pancréatite aiguë	166
3.4. Grands syndromes	168
4. Raisonnement étiologique devant les situations pathologiques courantes	173
4.1. Ascite.....	173
4.2. Ictère.....	175
8. Examen neurologique.....	177
1. Anatomie et rôles du système nerveux	177
1.1. Fonctions supérieures.....	177
1.2. Motricité.....	180
1.3. Sensibilité	181
1.4. Autres fonctions sensorielles.....	182
1.5. Maintien du tonus.....	182
1.6. Coordination et enchaînement des mouvements.....	182
2. Raisonnement en neurologie.....	182
3. Examen neurologique « minimal ».....	183
3.1. Signes fonctionnels.....	183
3.2. Latéralité.....	184
3.3. Signes physiques.....	184
4. Examen neurologique orienté, recherche des syndromes neurologiques	232
4.1. Système nerveux central (SNC).....	232
4.2. Syndromes mixtes (central et/ou périphérique).....	249
4.3. Syndrome neurogène périphérique (SNP).....	254
4.4. JNM et muscle.....	258

5. Situations neurologiques fréquentes	259
5.1. Céphalée et douleur faciale	259
5.2. Syndromes épileptiques.....	264
5.3. Accidents vasculaires cérébraux (AVC)	266
9. Examen de l'appareil locomoteur : rhumatologie et orthopédie	267
1. Généralités	268
2. Signes fonctionnels	268
2.1. Douleur.....	268
2.2. Gonflement articulaire	272
2.3. Raideur articulaire ou enraidissement, dérouillage.....	272
2.4. Impotence fonctionnelle.....	272
2.5. Blocage : rachidien, genou, doigt... ..	272
2.6. Troubles de la marche	273
2.7. Signes généraux	274
3. Examen physique articulaire.....	274
3.1. Squelette axial.....	274
3.2. Squelette périphérique.....	296
4. Raisonnement devant une ou plusieurs arthrite(s).....	338
4.1. Définition.....	338
4.2. Anamnèse	338
5. Examen physique osseux.....	340
10. Examen urologique	341
1. Signes fonctionnels urinaires (SFu).....	341
1.1. Douleur.....	341
1.2. Troubles mictionnels.....	343
1.3. Coloration des urines.....	345
1.4. Écoulement urétral	346
1.5. Hémospémie	347
1.6. Grosse bourse	347
1.7. Dysfonction érectile.....	347
2. Signes physiques	347
2.1. Constantes	347
2.2. Inspection des urines et BU.....	347
2.3. Examen des fosses lombaires (FL), des flancs et des hypochondres.....	348
2.4. Recherche de globe vésical.....	349
2.5. Examen de la prostate.....	350
2.6. Examen des bourses	350
2.7. Examen de la verge	352
2.8. Examen de l'urètre chez la femme	352
3. Orientation diagnostique devant les situations pathologiques courantes	353
3.1. Hématurie.....	353
3.2. Grosse bourse	353
3.3. Troubles de vidange vésicale.....	354
3.4. Troubles de la retenue.....	355
3.5. Incontinence urinaire (IU).....	355

11. Examen gynécologique – obstétrique.....	356
1. Signes fonctionnels.....	356
1.1. Douleurs ou algies pelviennes.....	356
1.2. Écoulements génitaux.....	358
1.3. Aménorrhée.....	360
1.4. Aménorrhée physiologique.....	361
1.5. Infertilité ou infécondité.....	362
1.6. Prurit génital.....	362
1.7. Signes fonctionnels urinaires.....	362
1.8. Seins.....	362
2. Points importants de l'anamnèse : spécificités.....	363
2.1. Gynécologie.....	363
2.2. Obstétrique.....	364
3. Examen physique.....	364
3.1. Abdomen.....	364
3.2. Seins.....	365
3.3. Examen pelvien.....	366
3.4. Particularités de l'examen obstétrique (parturiente).....	370
12. Examen hématologique et lymphatique	372
1. Syndrome anémique.....	372
1.1. Signes fonctionnels : syndrome anémique.....	372
1.2. Signes physiques.....	373
2. Syndrome infectieux.....	374
3. Syndrome hémorragique.....	374
3.1. Hémostase primaire.....	374
3.2. Coagulation ou hémostase secondaire.....	375
4. Syndrome tumoral.....	375
4.1. Signes « B ».....	375
4.2. Aires ganglionnaires superficielles.....	375
4.3. Examen de la bouche.....	382
4.4. Hépatomégalie.....	382
4.5. Splénomégalie.....	382
13. Examen oto-rhino-laryngologique (ORL) – Stomatologique	384
1. Fonction auditive.....	385
1.1. Signes fonctionnels.....	385
1.2. Examen physique.....	387
1.3. Examens complémentaires spécialisés.....	389
2. Fonction vestibulaire.....	389
2.1. Signes fonctionnels.....	389
2.2. Examen physique.....	390
2.3. Examens complémentaires.....	390
3. Larynx et organe vocal.....	391
3.1. Signes fonctionnels.....	391
3.2. Examen physique.....	391
3.3. Examens complémentaires.....	392
4. Cavité buccale et oropharynx.....	392
4.1. Signes fonctionnels.....	393
4.2. Examen physique.....	393

5. Fosses nasales et sinus.....	394
5.1. Signes fonctionnels.....	394
5.2. Examen physique.....	395
14. Examen ophtalmologique	397
1. Signes fonctionnels.....	397
1.1. Baisse d'acuité visuelle (BAV).....	398
1.2. Altération du champ visuel ou scotome positif.....	398
1.3. Phosphènes.....	398
1.4. Myodésopsies.....	398
1.5. Diplopie.....	398
1.6. Douleur oculaire.....	398
1.7. Photophobie.....	399
1.8. Métamorphopsies.....	399
1.9. Micropsie et macropsie.....	399
1.10. Héméralopie.....	399
1.11. Larmolement.....	399
1.12. Troubles des paupières.....	399
1.13. Prurit oculaire.....	399
1.14. Xérophtalmie.....	400
2. Regroupements syndromiques.....	400
2.1. Syndrome de fatigue visuelle.....	400
2.2. Syndrome maculaire.....	400
3. Examens ophtalmologiques par le spécialiste et signes physiques.....	400
3.1. Examens réalisés systématiquement.....	400
3.2. Examens réalisés pour anomalie clinique ou sur demande du clinicien.....	404
15. Examen dermatologique	407
1. Signe fonctionnel : prurit.....	407
2. Signes physiques.....	408
2.1. Généralités.....	408
2.2. Raisonnement en dermatologie.....	408
2.3. Topographie évocatrice des lésions.....	409
2.4. Lésions élémentaires initiales.....	409
2.5. Lésions élémentaires secondaires (remaniées).....	412
2.6. Atteinte des phanères.....	414
2.7. Regroupement syndromique.....	414
3. Phénomène de Raynaud.....	416
4. Brûlure.....	417
4.1. Évaluation de la surface brûlée : règle des 9 de Wallace.....	417
4.2. Évaluation du degré des brûlures.....	418
5. Allergies cutanées.....	418
5.1. Manifestations cutanées liées à une réaction allergique.....	418
5.2. Manifestations cutanées atopiques.....	419
5.3. Manifestations cutanées d'hypersensibilité retardée : eczéma de contact.....	420

16. Examen métabolique et endocrinologique	421
1. État nutritionnel.....	421
1.1. Anamnèse	421
1.2. Signes physiques	422
2. Thyroïde.....	424
2.1. Généralités	424
2.2. Signe fonctionnel : douleur.....	424
2.3. Examen physique.....	424
2.4. Dysthyroïdies	426
3. Diabète sucré.....	428
3.1. Symptômes d'hyperglycémie chronique.....	428
3.2. Formes cliniques.....	429
3.3. Complications chroniques.....	429
3.4. Complications aiguës	430
4. Hypoglycémie.....	430
4.1. Tableau clinique : syndrome d'hypoglycémie	430
4.2. Causes.....	431
5. Hypercorticisme.....	432
5.1. Tableau clinique : syndrome de Cushing	432
5.2. Étiologies	432
6. Insuffisance surrénale ou surrénalienne.....	433
6.1. Insuffisance surrénale chronique ou syndrome d'Addison	433
6.2. Insuffisance surrénale aiguë.....	434
7. Phéochromocytome et paragangliome	434
8. Acromégalie	434
9. Hyperprolactinémie.....	435
10. Insuffisance antéhypophysaire	435
11. Diagnostic biologique en endocrinologie	436
11.1. Dosages statiques	436
11.2. Dosages dynamiques	436
11.3. Dosages couramment réalisés	437
17. Examen psychologique – psychiatrique.....	438
1. Entretien psychiatrique.....	438
1.1. Mise en confiance du patient.....	438
1.2. Observation et écoute.....	439
1.3. Anamnèse	439
2. Classification des troubles en psychiatrie	440
3. Éléments de troubles psychiatriques à rechercher à l'interrogatoire	441
3.1. Usage de substances psychoactives.....	441
3.2. Troubles de la personnalité	441
3.3. Troubles psychiatriques.....	441
3.4. Manifestations somatiques associées.....	445
18. Urgences vitales.....	446
1. État de choc.....	446
1.1. Définition	446
1.2. Physiopathologie	446
1.3. Classification des chocs	447
1.4. Signes cliniques.....	447
1.5. Particularités du choc septique	448

2. Détresse respiratoire ou insuffisance respiratoire aiguë (IRA).....	448
2.1. Définition.....	448
2.2. Physiopathologie	449
2.3. Diagnostic clinique	449
2.4. Prise en charge immédiate	450
2.5. Étiologies classées par mécanismes	450
3. Confusion ou syndrome confusionnel.....	450
3.1. Définition.....	450
3.2. Critères diagnostiques	451
3.3. Points importants de l'examen clinique.....	451
3.4. Examens complémentaires systématiques.....	452
3.5. Étiologies.....	452
4. Coma.....	453
4.1. Définition.....	453
4.2. Profondeur du coma : échelle de Glasgow	453
4.3. Examen clinique du patient comateux.....	455
4.4. Étiologies et examens complémentaires.....	458
5. Polytraumatisé	459
5.1. Définition.....	459
5.2. Examen clinique immédiat.....	459
6. Arrêt cardio-respiratoire (ACR) : CAT devant un sujet inanimé suspect d'ACR	460
6.1. Faire le diagnostic d'ACR	460
6.2. Secourir	460
7. Surveillance.....	462
19. Particularités de l'examen en gériatrie	463
1. Définitions.....	463
2. Principales fonctions physiologiquement altérées par le vieillissement	463
3. Mode de révélation des maladies chez la personne âgée	464
4. Raisonnement global devant une maladie chez le sujet âgé.....	464
5. Particularités à prendre en compte dans le raisonnement	465
6. Syndrome démentiel	466
7. Causes de démence.....	468
20. Examen pédiatrique	469
1. Nouveau-né.....	470
1.1. Examen à la naissance	470
1.2. Examen obligatoire du 8 ^e jour.....	471
2. Nourrisson.....	474
2.1. Consultations de suivi.....	474
2.2. Situations pathologiques fréquentes : raisonnement	476
3. Petit et grand enfant.....	481
3.1. Alimentation	481
3.2. Croissance staturo-pondérale	481
3.3. Développement psychomoteur.....	481
3.4. Dépistage des troubles sensoriels.....	483
3.5. Vaccination	483

4. Adolescent.....	483
4.1. Alimentation et dépistage de l'obésité	483
4.2. Croissance et puberté.....	483
4.3. Scolarité et socialisation	484
4.4. Dépistage des anomalies rachidiennes : cyphose et scoliose	484
4.5. Vaccins	484
5. Douleur chez l'enfant : évaluer et traiter	484
5.1. Particularités.....	484
5.2. Évaluation.....	484
5.3. Traitements	485

Partie 3 – Sémiologie des examens complémentaires courants

21. Sémiologie biologique et néphrologique : examens

de laboratoire	489
1. Prélèvement sanguin veineux	489
1.1. Technique.....	489
1.2. Hématologie : NFS ou hémogramme.....	490
1.3. Hémostase (ou crase sanguine).....	495
1.4. Biochimie : ionogramme sanguin.....	497
1.5. Bactériologie : hémocultures.....	501
2. Exploration d'une anomalie lipidique (EAL, bilan lipidique)	501
2.1. Paramètres dosés	502
2.2. Dyslipidémies	502
3. Prélèvement sanguin artériel : gaz du sang.....	503
3.1. Technique.....	503
3.2. Paramètres mesurés	504
3.3. Interprétation des résultats	504
4. Ponction de LCR : ponction lombaire	506
4.1. Technique.....	506
4.2. Analyse bactériologique	509
4.3. Analyse biochimique	509
4.4. Analyse anatomopathologique	510
4.5. Autres : virologie	510
5. Ponction de liquide articulaire	510
5.1. Ponction du genou par voie latérale	510
5.2. Analyse du liquide et orientation diagnostique	511
6. Examens des urines.....	512
6.1. Bandelette urinaire (BU)	512
6.2. Examen cytotabériologique des urines (ECBU)	512
6.3. Ionogramme urinaire.....	513
7. Sérologies usuelles.....	513
7.1. Virus de l'immunodéficience humaine (VIH).....	513
7.2. Hépatites aiguës : hépatite A (VHA), E (VHE) et formes aiguës des hépatites B (VHB), D (VHD) et C (VHC).....	514
7.3. Hépatites chroniques.....	514
7.4. Généralités sur les autres sérologies.....	516

8. Sémiologie néphrologique.....	517
8.1. Physiopathologie	517
8.2. Régulation de l'état d'hydratation.....	518
8.3. Syndromes rénaux.....	520
22. Sémiologie radiologique	524
1. Généralités sur les examens d'imagerie médicale	524
1.1. Indication des examens complémentaires radiologiques (valable pour tout examen complémentaire)	524
1.2. Intérêts d'un examen radiologique (et de tout autre examen complémentaire)	524
1.3. Formulation d'une demande d'examen radiologique	525
1.4. Contre-indications des examens d'imagerie médicale	526
2. Radiographie standard.....	526
3. Tomodensitométrie (TDM) ou scanner ou scannographie.....	527
4. Échographie Doppler ou ultrasonographie.....	528
5. Imagerie par résonnance magnétique (IRM) ou rémnographie.....	529

Partie 4 – Tableaux sémiologiques

23. Check-list	533
-----------------------------	------------

Annexes

Normales de laboratoire.....	545
Liste des préfixes/suffixes grecs les plus courants	549
Index avec racines grecques (gr.) et latines (lat.)	551

Liste des abréviations pour la séméiologie clinique par appareils

AAG : asthme aigu grave	CLR : canal lombaire rétréci
ACR : arrêt cardio-respiratoire	CMU : couverture médicale universelle
AIC : accident ischémique cérébral <i>ou</i> infarctus cérébral	CPT : capacité pulmonaire totale (EFR)
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens	CRH : hormone de l'axe corticotrope
AIT : accident ischémique transitoire	CV : cardiovasculaire <i>ou</i> capacité vitale (EFR) <i>ou</i> champ visuel
AME : aide médicale d'État	DDB : dilatation des bronches
AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs	DDR : date des dernières règles
APLV : allergie aux protéines de lait de vache	DDS : distance doigts-sol
ATCD : antécédents	DEC : déshydratation extracellulaire
AV : acuité visuelle	DEP : débit expiratoire de pointe (<i>peak flow</i>)
AVC : accident vasculaire cérébral	DIC : déshydratation intracellulaire
AVF : algie vasculaire de la face	DLCO : diffusion libre du monoxyde de carbone (EFR)
BAN : battement des ailes du nez	DPN : dyspnée paroxystique nocturne
BAV : baisse d'acuité visuelle <i>ou</i> bloc auriculo-ventriculaire (ECG)	DRA : détresse respiratoire aiguë
BH : bilan hépatique	DSA : défibrillateur semi-automatique
BPCO : bronchopathie chronique obstructive	DTS : désorientation temporo-spatiale
bpm : battements par minute	E : extension
BREF : batterie rapide d'efficienne frontale	ECG : électrocardiogramme
BTA : balancement thoraco-abdominal	EFR : épreuves fonctionnelles respiratoires
BU : bandelette urinaire	EIAS : épine iliaque antéro-supérieure
CAE : conduit auditif externe	EICG/EICD : espace intercostal gauche/droit
CAT : conduite à tenir	EME : état de mal épileptique
CBP : cancer broncho-pulmonaire	EN : échelle numérique
CCH : crise convulsive hyperthermique	EP : embolie pulmonaire
CDA : consommation déclarée d'alcool	ESA : extrasystole auriculaire (ECG)
CEE : choc électrique externe	ESV : extrasystole ventriculaire (ECG)
CIA : communication interauriculaire	EVA : échelle visuelle analogique
CIV : communication interventriculaire	EVS : échelle verbale simple
	F : flexion
	FA : fibrillation auriculaire (ECG)

FC : fréquence cardiaque	JNM : jonction neuro-musculaire
FL : fosse lombaire	LCA : ligament croisé antérieur
FLM : faisceau longitudinal médian	LCP : ligament croisé postérieur
FR : facteur de risque <i>ou</i> fréquence respiratoire	LCR : liquide céphalo-rachidien
FSH : hormone sexuelle	LDL : cholestérol (<i>low density lipoprotein</i>)
FP : fémoro-patellaire	LLE : ligament latéral externe
GCS : <i>Glasgow coma scale</i> (échelle de Glasgow)	LLI : ligament latéral interne
GEA : gastroentérite aiguë	LH : hormone sexuelle (<i>luteinizing hormone</i>)
GH : <i>growth hormon</i> (hormone de croissance)	LVAS : liberté des voies aériennes supérieures
GnRH : hormone sexuelle	MAF : mouvements actifs fœtaux
Hb : hémoglobine	MCE : massage cardiaque externe
HCD/HCG : hypochondre droit et gauche	MCP : articulation métacarpo-phalangienne
HDL : cholestérol (<i>high density lipoprotein</i>)	MDV : mode de vie
HDM : histoire de la maladie	MI : membre(s) inférieur(s)
HTA : hypertension artérielle	MMSE : <i>mini mental state examination</i> ou test de Folstein
HTAP : hypertension artérielle pulmonaire	MS : membre(s) supérieur(s)
HTIC ou HIC : hypertension intracrânienne	MST : maladie sexuellement transmissible
HU : hauteur utérine	MTE : maladie thrombo-embolique
IA : insuffisance aortique	MTP : articulation métatarso-phalangienne
ICD : insuffisance cardiaque droite	NCB : névralgie cervico-brachiale
ICG : insuffisance cardiaque gauche	NYHA : classification de dyspnée de la New York Heart Association
IDM : infarctus du myocarde	OAP : œdème aigu pulmonaire
IIA : invagination intestinale aiguë	OGE : organes génitaux externes
IM : insuffisance mitrale	OIN : ophtalmoplégie internucléaire
IMC : indice de masse corporelle	OMS : organisation mondiale de la santé
IPD : articulation interphalangienne distale	ORL : oto-rhino-laryngologie/-iste
IPP : articulation interphalangienne proximale	P : poids
IRA : insuffisance rénale ou respiratoire aiguë	P1, P2, P3 : 1 ^e , 2 ^e et 3 ^e phalanges
IST : infection sexuellement transmissible	PA : pression artérielle (ou TA) <i>ou</i> paquets-année (tabac)
IU : incontinence urinaire	PAd : pression artérielle diastolique
IV : intraveineux	PAM : pression artérielle moyenne
	PAs : pression artérielle systolique

PC : périmètre crânien	SNP : système nerveux périphérique <i>ou</i> syndrome neurogène périphérique
PFC : paralysie faciale centrale	SP : signes physiques
PFLA : pneumonie franche lobaire aiguë	Sp : spécificité
PFP : paralysie faciale périphérique	SpO ₂ : saturation percutanée en oxygène
PIC : pression intracrânienne	T : taille
PN : poids de naissance	TA : tension artérielle
PNO : pneumothorax	TdP : torsade de pointe (ECG)
POM : paralysie oculomotrice	TG : triglycérides
POMC : pro-opio-mélano-cortine (hormone précurseur des corticoïdes)	TJ : turgescence jugulaire <i>ou</i> tachycardie jonctionnelle (ECG)
PRL : prolactine (hormone)	TN : taille de naissance
RA : rétrécissement aortique	TRC : temps de recoloration cutanée
RAJ : reflux abdomino-jugulaire	TS : tentative de suicide
RAU : rétention aiguë d'urines	TRH-TSH : hormones thyroïdiennes
RCA : réflexe cutané abdominal	TSV : tachycardie supra-ventriculaire (ECG)
RCP : réflexe cutané plantaire	TT : tour de taille
RCP : réanimation cardio-pulmonaire	TV : tachycardie ventriculaire (ECG)
RE : rotation externe	TVP : thrombose veineuse profonde
RGO : reflux gastro-œsophagien	TVS : thrombose veineuse superficielle
RHJ : reflux hépato-jugulaire	UAI : unité alcool internationale
RI : rotation interne	UGD : ulcère gastro-duodénal
RM : rétrécissement mitral	VBP : voie biliaire principale
RPM : réflexe photomoteur	VD : ventricule droit
RS : rapports sexuels	VG : ventricule gauche
SAOS : syndrome d'apnée obstructive du sommeil	VHB, VHC : virus de l'hépatite B, C
SB : substance blanche	VIH : virus d'immunodéficience humaine
SC : sous-cutanée	VPPB : vertige paroxystique positionnel bénin
SCA : syndrome coronaire aigu	VR : volume résiduel (EFR)
SCM : muscle sterno-cléïdo-mastoïdien	VRE : volume de réserve expiratoire (EFR)
Se : sensibilité	VRI : volume de réserve inspiratoire (EFR)
SF : signes fonctionnels	VT : volume courant (EFR)
SG : substance grise <i>ou</i> signes généraux	VV : vibrations vocales
SI : sacro-iliaques	
SNC : système nerveux central	

Listes des abréviations pour la sémiologie biologique et radiologique

BU : bandelette urinaire
CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine
CIVD : coagulation intravasculaire disséminée
CMV : cytomégalo virus
CPK : créatine phospho-kinase
CRP : *C-reactiv protein* (protéine C-réactive)
CST : coefficient de saturation de la transferrine
CTF : capacité totale de fixation de la transferrine
DFG : débit de filtration glomérulaire
EAL : exploration d'une anomalie lipidique (bilan lipidique)
EBV : *Epstein Barr virus* (virus de la mononucléose infectieuse)
ECBU : examen cyto bactériologique des urines
EPO : érythropoïétine
G/L : giga/litre
gGT : gammaglutamyl transférase
GR : globules rouges
Hb : hémoglobine
HSV : *herpes simplex virus*
Ht : hématocrite
IRM : imagerie par résonnance magnétique
LCR : liquide céphalo rachidien
LLC : leucémie lymphoïde chronique
LMC : leucémie myéloïde chronique

NFS : numération formule sanguine
PAL : phosphatases alcalines
PCI : produit de contraste iodé
PDF : produits de dégradation de la fibrine
PFA 100 : *platelet fonctionnal analyser* (automate permettant la mesure du TS *in vitro* ou temps d'occlusion)
PNB ou PB : polynucléaires basophiles
PNE ou PE : polynucléaires éosinophiles
PNN ou PN : polynucléaires neutrophiles
PTH : parathormone
TCA : temps de céphaline activée
TCK : temps de céphaline Kaolin (équivalent TCA)
TCMH : teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
TDM : tomodensitométrie ou scanner
TP : taux de prothrombine (idem TQ temps de Quick)
TQ : temps de Quick (préférer le terme de TP)
TS : temps de saignement
VHA : virus de l'hépatite A
VHB : virus de l'hépatite B
VHC : virus de l'hépatite C
VHD : virus de l'hépatite D
VHE : virus de l'hépatite E
VGM : volume globulaire moyen
VS : vitesse de sédimentation

Partie

1

Méthodologie

Conseils méthodologiques

1

1 Définitions

Voici quelques définitions générales nécessaires à la compréhension de l'ensemble des chapitres. Les nuances sont importantes à maîtriser.

♦ Maladies et pathologies

Une maladie ou affection est une altération d'une fonction ou de la santé de l'organisme. La pathologie est l'étude des maladies notamment les causes (étiologies), mécanismes (physiopathologie). « Pathologie » est utilisé par abus de langage comme synonyme de maladie.

♦ Physiologie et physiopathologie

Études du fonctionnement des organes normaux et des organes pathologiques.

♦ Maladie symptomatique, paucisymptomatique, asymptomatique

On parle de maladie symptomatique lorsqu'elle s'exprime par des signes fonctionnels. Elle est paucisymptomatique lorsqu'elle s'exprime peu ou par des symptômes banals. Une maladie est asymptomatique lorsqu'elle évolue silencieusement.

♦ Démarche systématique

Raisonnement rigoureux qui consiste à tout rechercher dans un ordre précis.

♦ Diagnostic et diagnostic différentiel

Le diagnostic est le regroupement des signes cliniques et des examens complémentaires en un syndrome ou en une maladie.

Les diagnostics différentiels sont **les maladies ou syndromes** qui peuvent être **compatibles avec une situation clinique donnée** (appendicite et grossesse extra-utérine, ulcère et lithiase biliaire...).

♦ Comorbidités

Maladies dont souffre le malade. On utilise souvent ce terme pour des pathologies chroniques ayant un retentissement important sur la santé et à risque de « décompensation », c'est-à-dire d'aggravation brutale (insuffisance cardiaque, diabète...).

Le terme de tare viscérale est à proscrire.

♦ Étiologies

Causes d'une maladie :

- idiopathique : **cause** inconnue ;

- iatrogène : maladie due à des traitements médicaux ;
- essentielle ou commune : termes utilisés en rhumatologie pour désigner les causes mécaniques fréquentes pour les douleurs du rachis d'origine discale ;
- fonctionnelle : qualifie une cause fréquente, bénigne, sans lésion décelable de l'organe symptomatique (par exemple, trouble fonctionnel intestinal) ;
- organique : maladie associée à une lésion décelable de l'organe en cause (par opposition à fonctionnel) ;
- maladie générale ou maladie systémique : maladie atteignant plusieurs organes ou structures (vaisseaux, nerfs...) ;
- maladie dysimmunitaire, auto-immune : maladie liée au dérèglement du système immunitaire qui réagit de façon exagérée à des stimulations extérieures, voire contre les organes du malade lui-même (maladie auto-immune).

♦ **Traitements**

Moyens prescrits par le médecin pour lutter contre les symptômes ou la maladie :

- symptomatique : traitement visant à soulager les signes fonctionnels sans s'intéresser à la maladie causale ;
- probabiliste ou présomptif : terme utilisé pour les traitements anti-infectieux lorsque l'agent pathogène n'est pas connu mais que la situation nécessite de traiter les germes les plus souvent en cause, immédiatement ;
- étiologique : traitement spécifique de la maladie (antibiotiques si infection bactérienne, exérèse pour un cancer du côlon...) ;
- curatif : dont l'objectif est une guérison du patient ;
- palliatif : dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des malades.

♦ **Pronostic**

Évolution probable de la maladie ou des symptômes du patient.

♦ **Tumeur**

Prolifération cellulaire dérégulée :

- bénigne ou processus bénin : tumeur qui n'entraîne pas de risque vital pour le malade. Une tumeur bénigne peut être agressive lorsqu'elle entraîne des dommages locaux importants ;
- maligne ou cancer, ou processus malin : tumeur menaçant la vie du malade :
 - ▷ cancer solide/hémopathie maligne : on oppose souvent les cancers solides (origine tissulaire) aux cancers hématologiques ou hémopathies malignes (origine : cellules circulantes sanguines ou lymphatiques) ;
 - ▷ extension locale : développement d'une tumeur en taille dans les organes pleins, en profondeur pour les organes creux avec éventuelle atteinte des structures de voisinage (vaisseaux, nerfs, organes) ;

- ▷ extension régionale : atteinte des ganglions situés à proximité de la tumeur maligne d'origine;
 - ▷ extension à distance (métastases) : c'est le risque évolutif de la majorité des cancers avec dissémination dans l'organisme et localisation préférentielle aux organes bien vascularisés. La dissémination des cellules cancéreuses à partir de la tumeur initiale se fait souvent par les vaisseaux sanguins (dissémination hémotogène), parfois lymphatiques, ou par contiguïté ;
 - localisation primitive et secondaire : la localisation primitive d'une tumeur est le site de départ du cancer. Les localisations secondaires sont les sites métastatiques (poumon, cerveau, os...);
 - synchrone/métachrone : ces termes sont utilisés pour qualifier le moment de découverte des métastases ou d'un autre cancer par rapport à celui du primitif. Lorsque les métastases sont découvertes en même temps que la tumeur primitive, on parle de métastases synchrones (ou cancer d'emblée métastatique). Lorsque les métastases apparaissent alors que le cancer primitif est déjà connu, on parle de métastases métachrones;
 - syndrome paranéoplasique : manifestations cliniques survenant au cours d'un cancer et sans lien avec l'organe touché initialement. Ces manifestations sont souvent diffuses (endocrines, neurologiques, hématologiques...).
- ♦ **Sémiologie**
- La sémiologie est l'étude des **symptômes** (plaintes exprimées par le malade) et des **signes** des maladies. Elle s'intéresse donc aux signes cliniques recherchés par l'examen clinique.
- ♦ **Examen clinique**
- L'examen clinique se déroule en 2 temps : l'anamnèse ou l'interrogatoire, puis la recherche de signes physiques :
- **l'anamnèse** est essentielle dans l'orientation du diagnostic. Elle a 2 objectifs principaux :
 - ▷ partir de la « plainte » du malade et la préciser. Les symptômes que peut rapporter le malade sont appelés **signes fonctionnels ou SF**. Ce sont les **signes subjectifs qui traduisent l'altération de fonction d'un organe**. L'objectif est de préciser ces symptômes pour orienter le diagnostic (exemple : type de douleur);
 - ▷ anamnèse orientée : elle est difficile lorsque les pathologies ne sont pas connues. Elle consiste à poser des questions qui argumenteront ou réfuteront les principales hypothèses. Elle recherche d'autres SF sans lien apparent mais aussi des informations générales tels les antécédents, les facteurs de risque, les traitements... Elle peut donc se dérouler dès le recueil des SF lorsque l'orientation est évidente, après l'examen

physique voire après certains examens complémentaires dans les cas les plus difficiles ;

- **signes fonctionnels** ou **SF** – symptômes : bien différencier les SF rapportés par le patient de ceux recherchés par l'interrogatoire ;
- **signes physiques** ou **SP** : **signes recherchés par les manœuvres d'examen physique**. Il faut toujours raisonner schématiquement, appareil par appareil, avec la séquence **IPPA** (**i**nspection, **p**alpation, **p**ercussion, **a**uscultation). La convention veut que l'on examine le patient en se plaçant toujours sur sa droite ;
- **décubitus** : position « allongé » du malade. On parle de **décubitus dorsal** (sur le dos), latéral (sur le côté droit ou gauche), ventral ou **procurbitus** (sur le ventre), déclive (tête plus haut que les pieds) ou proclive (tête en bas).
- ♦ **Syndrome**

C'est un **ensemble de symptômes et/ou de signes physiques**. Il porte souvent le nom du médecin qui l'a découvert et il oriente vers une cause ou un groupe de causes.

2 Méthode d'apprentissage de la sémilogie

Ce qui est attendu de l'étudiant : les objectifs sont différents en fonction du cursus de l'étudiant.

- ♦ **Un étudiant en DFGSM2 (ex-P2) ou DFGSM3 (ex-D1)** qui ne connaît pas la pathologie devra apprendre la sémilogie essentiellement par l'acquisition du vocabulaire et la recherche des signes physiques. Il est nécessaire de savoir énumérer les SF de chaque appareil. Il faut essayer d'être systématique et ne rien oublier. La partie 4 « Check-list » vous aidera au lit du malade. Il faut également bien comprendre le raisonnement de l'examen clinique et vous l'approprier.
- ♦ **Pendant l'externat**, l'apprentissage des pathologies permet de revenir sur une sémilogie orientée qui se rapproche de ce que fait un médecin en consultation. L'anamnèse permet de sélectionner 2 ou 3 étiologies qui seront argumentées par l'examen physique et, si nécessaire, par des examens complémentaires.
Il ne s'agit pas de réaliser un examen clinique exhaustif mais de rechercher les informations et les signes physiques qui peuvent modifier la prise en charge, sans se perdre dans les détails.
Il s'agit également d'éliminer les **pathologies fréquentes et/ou graves**. Cet examen n'est possible que lorsque les pathologies sont suffisamment connues et lorsque l'étudiant connaît l'ensemble des tableaux cliniques.
- ♦ **Pour un étudiant en fin de deuxième cycle** qui prépare les ECN, l'objectif est une révision des tableaux sémiologiques en mots-clés.

À noter qu'une connaissance minimum de l'anatomie est nécessaire pour comprendre chaque appareil.

3 Valeur des tests en médecine

La valeur des différents éléments de l'examen clinique et des examens complémentaires peut être appréciée par différents paramètres, reflétant l'intérêt ou non d'un signe clinique, d'une manœuvre d'examen physique, d'une radiographie... Ces éléments sont systématiquement pris en compte dans cet ouvrage.

Pour l'examen clinique, l'intérêt est de rechercher des signes qui apporteront une aide importante pour affirmer ou éliminer un syndrome, une hypothèse étiologique. Pour les examens complémentaires, il faut prendre en considération que certains examens lourds peuvent nuire au malade, et **favoriser les examens non invasifs**.

On différencie également l'ordre de réalisation des examens. Lorsqu'on cherche à dépister une maladie dans une grande population, on ne peut effectuer un **test invasif** ou un test qui dépiste des « **faux-positifs** » (non malade ayant un examen de dépistage positif) car les autres examens qui chercheront à confirmer la maladie seront invasifs. De même, il faut éviter de passer à côté de certains malades, les **faux négatifs** (personnes malades mais test négatif).

On définit ainsi les résultats possibles pour une manœuvre d'examen clinique ou un examen complémentaire, dans une population donnée et en comparaison avec un test de référence qui affirme le diagnostic de maladie ou non (*gold standard*) :

	Test positif T+	Test négatif T-	
Malades M	Vrais positifs VP	Faux négatifs FN	Sensibilité = $VP/(VP + FN)$
Non malades NM	Faux positifs FP	Vrais négatifs VN	Spécificité = $VN/(VN + FP)$
	$VPP = VP/(VP + FP)$	$VPN = VN/(VN + FN)$	

On définit ainsi les paramètres suivants :

- ♦ **sensibilité** : proportion de malades détectés par le test ou probabilité que le test soit positif lorsqu'on est malade soit $VP/(VP + FN)$;
- ♦ **spécificité** : proportion de sujets sains détectés ou probabilité que le test soit négatif lorsqu'on est pas malade soit $VN/(VN + FP)$;
- ♦ **VPP** (valeur prédictive positive) : probabilité d'être malade sachant que le test est positif soit $VP/(VP + FP)$;

- ♦ **VPN** (valeur prédictive négative) : probabilité d'être sain sachant que le test est négatif soit $VN/(VN + FN)$.

La sensibilité et spécificité ne varient pas pour un test. Dans l'idéal, un test doit être très sensible et spécifique mais cela existe rarement. En pratique, on utilise **un test très sensible en dépistage pour éviter les FN et un test très spécifique pour confirmer une suspicion de maladie pour minimiser les FP**. On parle de **test pathognomonique** lorsque la présence d'un signe affirme un diagnostic. Cependant, ces données décrivent les caractéristiques d'un test dans une population où la fréquence de la maladie est connue et servent principalement à dégager des stratégies de dépistage ou de diagnostic.

La VPP et VPN permettent d'apprécier en quoi le test augmente ou diminue la probabilité d'un diagnostic selon son résultat. Cependant, les valeurs de VPP et VPN varient selon la prévalence de la maladie.

Par exemple, suspecter une insuffisance cardiaque dans une population de sujets jeunes comparée à des sujets après 80 ans modifie les valeurs de VPP et VPN. Le test doit donc être validé dans une population donnée et ne sera pas valable dans d'autres. **Une forte VPP confirmera le diagnostic** (en cas de positivité du test), **une forte VPN l'éliminera** (en cas de négativité du test).

D'autres paramètres reflètent l'intérêt d'un test pour confirmer ou réfuter un diagnostic et en particulier les **rapports de vraisemblance** (RV). Ils permettent de connaître la probabilité de la maladie après un ou plusieurs tests en connaissant les caractéristiques invariables (sensibilité et spécificité) et la prévalence a priori (probabilité initiale de maladie dans la population dont est issu le malade) :

- ♦ **RV+ positif** : pour un test positif, fraction de VP/fraction de FP soit $\text{sensibilité}/(1 - \text{spécificité})$. Ainsi un RV supérieur à 1 augmente la probabilité d'avoir la maladie de RV+ fois ;
- ♦ **RV- négatif** : pour un test négatif, fraction de FN/fraction de VN soit $(1 - \text{sensibilité})/\text{spécificité}$. Ainsi un RV inférieur à 1 diminue la probabilité d'avoir la maladie de RV- fois.

Ces données sont principalement utilisées dans les essais cliniques. Dans la pratique courante, ils permettent de déterminer les signes cliniques utiles ou inutiles, les examens complémentaires essentiels ou non devant une situation clinique.

Observation médicale

2

1 Introduction

C'est la trace écrite et mise en forme de l'examen clinique et de la réflexion qui en découle.

Son plan est précis, mais l'ordre va varier en fonction de l'expérience du clinicien.

- ◆ Pour l'étudiant en début de cursus médical : les pathologies n'étant quasiment pas connues, il faut s'efforcer d'être exhaustif et systématique en examinant tous les appareils rigoureusement (*cf. chapitre 23, Check-list*), s'habituer au vocabulaire, rassembler les symptômes et signes en syndromes. Les observations sont nécessairement peu orientées par méconnaissance des maladies et beaucoup d'informations peu utiles seront recueillies, ce n'est pas grave !
- ◆ **Pour l'étudiant en fin de cursus et le jeune interne** : les pathologies sont globalement connues et le temps disponible pour examiner le patient est important, comparé à une consultation programmée. L'examen doit être orienté par l'anamnèse et par un examen clinique complet. Les hypothèses diagnostiques doivent être argumentées et une conduite à tenir diagnostique et thérapeutique doit être dégagée.
- ◆ Pour le médecin confirmé généraliste ou spécialiste ou pour l'interne aux urgences : les pathologies sont connues et les délais nécessitent d'axer son examen clinique sur la pathologie ayant motivé le patient à consulter. On commence par l'histoire de la maladie détaillée. Celle-ci permet généralement de dégager des hypothèses diagnostiques qu'on étayera ou réfutera par des questions précises orientées et discriminantes sur le symptôme, les antécédents, les traitements pris... L'examen clinique vient, lui, corroborer les hypothèses diagnostiques. Il recherche avant tout les **signes de gravité** imposant des traitements immédiats ou une hospitalisation, a fortiori en contexte aigu, puis il étudie les appareils symptomatiques.

2 Intérêt de l'examen clinique

Pendant le cursus médical, la place de l'examen clinique va beaucoup varier pour l'étudiant.

Au début, il est au centre puisque non connu et il sera l'objet d'un investissement important pour acquérir le vocabulaire et la réalisation pratique de l'examen physique.

Lorsque vient l'externat, la place est donnée à l'apprentissage des pathologies en considérant que l'examen clinique est acquis (ce qui est rarement le cas). L'étudiant se trouve alors face à une somme de connaissances à acquérir et n'a plus le temps de revenir sur l'examen clinique. De plus, il apprend, avec beaucoup d'admiration, toutes les nouvelles techniques complémentaires (biologie, imagerie...) pour faire le diagnostic au détriment de l'examen clinique.

Enfin, lorsqu'on devient praticien, confronté aux limites administratives ou techniques des examens complémentaires, on souhaite raisonner à nouveau cliniquement.

Pour étayer l'importance de l'anamnèse, 2 petits clins d'œil :

- ♦ de nombreux professeurs se sont approprié l'**aphorisme d'Alajouanine** : « Si vous n'avez pas fait votre diagnostic à l'interrogatoire, vous ne le ferez jamais. » Ce n'est pas si caricatural que ça en a l'air ;
- ♦ plusieurs études concernant l'**efficacité diagnostique de l'examen clinique** pour divers symptômes ont démontré l'importance de l'anamnèse et des signes physiques, reléguant l'impact des examens complémentaires au second plan ou dans le but de se rassurer : Roshan et Rao, en 2001, ont montré que dans 79 % des cas, l'anamnèse suffisait à faire le diagnostic. Dans 8 % des cas, c'est au stade de l'examen physique que le diagnostic a été fait et dans seulement 13 % avec les examens complémentaires ; Peterson et Holbrook en 1992 avaient déjà donné des chiffres semblables : 76 % pour l'anamnèse, 12 % pour l'examen physique et 11 % pour les examens complémentaires.

Prenez du temps pour interroger vos malades et surtout, **adaptez votre langage** à leur niveau de compréhension.

Pour les patients non communicants ou ne parlant pas une langue commune, il est primordial de se renseigner auprès de l'entourage proche, des médecins, en faisant appel à un interprète (téléphonique ou personne physique) ou en récupérant les dossiers précédents s'ils existent.

3 Écriture de l'observation médicale

Sur le plan formel, quelques **conseils** :



- ♦ écrire très lisiblement ;
- ♦ éviter les phrases, les abréviations, ou n'utiliser que celles qui sont communément admises et connues par tous les médecins (HTA, P, HIC...). Attention, certaines abréviations n'ont pas le même sens en fonction de la spécialité (BAV : bloc auriculo-ventriculaire en cardiologie, baisse d'acuité visuelle en ophtalmologie) : cf. la liste, p. XIX ;

- ♦ faire ressortir le plan ;
- ♦ éviter les approximations et les termes non médicaux : « bilan », « a priori... »

Pour l'étudiant en formation, il est nécessaire de tout détailler, par exemple :

- ♦ **ne pas noter** « absence de syndrome méningé » sans en préciser la justification (on est donc sûr d'avoir recherché ces manœuvres : pas de céphalée, pas de vomissement, pas de photo-phonophobie, pas de raideur de nuque, pas de signe de Kernig...);
- ♦ **ne pas noter** « examen des nerfs crâniens normal », mais énumérer chaque nerf crânien testé et, pour chacun d'eux, les manœuvres et les résultats. En général, l'examen complet des nerfs crâniens est long à assimiler ; il faut donc savoir rester humble et ne noter que ce que l'on connaît.

En étant relu par un senior, vous pourrez obtenir des critiques constructives. L'effort réalisé en se récitant l'ensemble de l'examen clinique permet, lors de chaque révision, appareil par appareil, de se rendre compte de ce qui a été acquis ou oublié.

4 Plan de l'observation médicale

Le plan minimal d'une observation est le suivant :



- ♦ date et identification du clinicien ;
- ♦ motif de consultation ou d'hospitalisation ;
- ♦ anamnèse systématique ;
- ♦ anamnèse orientée ;
- ♦ examen physique ;
- ♦ résultats des examens complémentaires déjà effectués : biologie, imagerie, endoscopie ou autre ;
- ♦ conclusion avec résumé et regroupement syndromique, hypothèses étiologiques argumentées, conduites à tenir diagnostique et thérapeutique.

5 Conclusion

La conclusion est une étape très importante pour laquelle il est nécessaire de passer du temps et de faire des propositions, sans avoir peur de se tromper.

Vous avez le droit de noter vos réflexions dans le dossier médical et celles-ci ne seront pas transmises lorsque le malade demande l'accès à son dossier. C'est ainsi qu'on apprend à résumer l'examen clinique avec les informations importantes, proposer des diagnostics et les modalités pour le confirmer, puis proposer un traitement. C'est en faisant des erreurs que l'on progresse, donc plus « on se mouille », meilleur sera l'apprentissage.

6 L'observation médicale en pratique

Voici une manière conseillée de présenter une observation médicale et un contenu minimal :

- ♦ observation médicale (titre);
- ♦ date;
- ♦ heure (la nuit ou en cas de modification rapide de l'état de santé du patient);
- ♦ nom du clinicien (qualification : étudiant, externe...);
- ♦ M. ou Mme D, âge, consulte pour... ou est hospitalisé pour...; puis :
 - décrire les symptômes ayant nécessité un avis médical si diagnostic non fait;
 - donner le diagnostic si déjà fait (attention, toujours vérifier comment il a été posé et remettre en question les informations de tiers);
 - investigations complémentaires : en détaillant (endoscopie...);
 - traitement d'une pathologie donnée : perfusion de médicament, chimiothérapie...
- ♦ coordonnées des médecins (généraliste, spécialiste) : nécessaires pour les informer de la consultation ou de l'hospitalisation de leur malade ou leur demander des informations médicales;
- ♦ **personne de confiance** et coordonnées : c'est une personne choisie par le patient, qui peut accompagner celui-ci pendant l'hospitalisation et qui doit être consultée lorsque le patient ne peut pas communiquer. C'est un droit du patient et c'est un devoir du médecin de proposer cette personne de confiance.

6.1. Interrogatoire général ou systématique

Il peut au choix débiter par l'histoire de la maladie (conseillé car il permet de cibler les antécédents pertinents, de poser des questions orientées sur le mode de vie...), ou terminer par celle-ci. L'interrogatoire doit dans tous les cas comporter les informations suivantes.

6.1.1. *HDM (histoire de la maladie)*

C'est le **recueil des informations concernant l'épisode actuel**.

L'histoire traduit les plaintes du malade (signes fonctionnels) ayant motivé la consultation en termes médicaux et elle précise pour chacune ses caractéristiques (appries pour chaque appareil).

Elle précise également la chronologie avec les dates. Lorsque deux maladies évoluent sans lien apparent, on séparera volontiers l'histoire de chacune. On note également si des traitements ont déjà été administrés pour ces symptômes, leur efficacité, leur durée...

Le but à ce stade est seulement de préciser les symptômes spontanément rapportés par le patient. Il vaut mieux éviter d'en rechercher d'autres car il est facile de se perdre et d'oublier les symptômes qui sont au-devant de la scène. On doit prendre en compte ce critère de symptôme prédominant car le but premier est de soulager le patient des symptômes les plus gênants.

6.1.2. *ATCD (antécédents)*

Ce sont les **antériorités**, les maladies dont souffre ou dont a souffert le malade.

Demander « Avez-vous des antécédents ? » ne suffit pas. La majorité répondront non alors qu'en creusant un peu, on trouve beaucoup de renseignements.

L'idéal est de rechercher les antécédents apportant des arguments pour le diagnostic. Par exemple, devant une jambe tuméfiée inflammatoire, demander au patient s'il a des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire, s'il a été alité ou opéré récemment est capital.

On pourra également rechercher plus tard certains antécédents sélectivement, par exemple, au moment de prescrire un traitement (vérifier l'absence d'allergie...).

Néanmoins, certaines questions simples permettent d'obtenir les informations principales.

♦ **ATCD personnels médicaux :**

« Êtes-vous suivi pour une ou pour plusieurs maladies ? Avez-vous déjà été hospitalisé ou avez-vous déjà consulté un médecin ? Pour quelles raisons ? »

Toujours préciser la **chronologie** et les dates, si possible le lieu du suivi, le nom du médecin, les **traitements administrés** et leur **efficacité**, les **séquelles** en cas de pathologie sévère ou à risque de guérison partielle (AVC, brûlure, IDM...).

♦ **ATCD chirurgicaux :**

« Avez-vous déjà été opéré ? » Préciser alors le type d'intervention en termes chirurgicaux, la chronologie, le site anatomique, les éventuelles complications du geste opératoire.

- ♦ **Allergies** : surtout **médicamenteuses**, en précisant les symptômes ayant fait porter le diagnostic d'allergie à tel médicament. En effet, il est extrêmement fréquent que le patient attribue lui-même le terme d'allergie à des effets secondaires classiques et cette information fautive peut ensuite se transmettre d'hospitalisation en hospitalisation. Or, certains traitements sont parfois d'une nécessité vitale (antibiotiques, aspirine...).
- ♦ **ATCD gynécologiques** : demander si la patiente a un suivi régulier, notamment frottis et mammographie (après 50 ans tous les 2 ans). Le cas échéant, on expliquera l'utilité du dépistage à la patiente et on l'orientera (après l'avoir examinée) vers un gynécologue.

Les informations importantes :

- **DDR** (date des dernières règles) surtout chez la femme en âge de procréer chez qui une grossesse doit être éliminée avant d'instaurer certains traitements, ou de réaliser des examens d'imagerie irradiant sur l'abdomen ;
- mode de **contraception** et observance (régularité des prises) ;
- pathologies suivies.
- ♦ **ATCD obstétricaux** :

« Avez-vous eu des enfants ou avez-vous été enceinte ? »

Préciser le nombre de grossesses (**gestité**) incluant les fausses-couches et les grossesses extra-utérines, et la **parité** (nombre d'enfants selon la définition de viabilité : poids > 500 g ou ayant dépassé le terme de 22 semaines d'aménorrhée ou SA).

Ces 2 informations seront notées G...P... avec le nombre.

On précise pour les grossesses précédentes : poids à la naissance, déroulement de la grossesse, mode d'accouchement (voie basse ou césarienne).

- ♦ **ATCD familiaux** (± arbre généalogique) :

La question : « Avez-vous des antécédents familiaux ? » est trop vague, souvent incomprise. « Y a-t-il des personnes malades dans votre famille ? » peut apporter des informations mais le plus rentable est de demander au patient d'énumérer chaque personne de sa famille (au moins au premier degré : parents, fratrie, enfants) en précisant leur âge et leurs pathologies éventuelles, et, en cas de décès, l'âge et la cause.

Devant une suspicion de maladie familiale chez le patient ou dans l'histoire familiale, on dessinera un **arbre généalogique**.

6.1.3. Traitements en cours

Préciser la galénique (comprimés, gélules, injections, etc.), la posologie et la chronologie d'introduction.

6.1.4. Mode de vie (MDV) ou habitus (curriculum vitæ)

Ce sont les **habitudes de vie** du patient dans des domaines variés (alimentation, consommation de toxiques, emploi, lieu de vie...).

Très important, il regroupe des informations essentielles pour une prise en charge globale, notamment sociale, et la compréhension de la maladie.

Facteurs de risque (FR) principaux : maladies cardiovasculaires, cancers

Un facteur de risque est une **habitude de vie** (on parle d'exposition) **reliée à un risque plus élevé de développer une ou plusieurs maladies** données. De plus, le FR est **dose-dépendant** (le risque augmente avec l'importance de l'exposition), **réversible** (le risque diminue avec le temps après l'arrêt de l'exposition au FR).

Dès qu'on aborde les FR, il faut au minimum donner un message de **prévention** avec des **objectifs** à atteindre. On différencie **3 types de prévention** :

Prévention primaire	Empêche la survenue d'une maladie
Prévention secondaire ou dépistage	Détecte la maladie tôt pour éviter une évolution grave
Prévention tertiaire	La maladie existe et on cherche à stopper son évolution, éviter une récurrence

Les termes qui culpabilisent le patient sont à proscrire (par exemple, le patient « avoue » boire 3 bières...).

Cinq FR sont précisés systématiquement.

♦ 1. Tabac :

- dose et degré de dépendance :
 - ▷ **durée d'exposition** : FR principal (une durée doublée multiplie le risque de cancer par 20 environ alors que le doublement de la dose le décuple). On la calcule en soustrayant l'âge de début à l'âge d'arrêt, ou âge actuel si le malade n'est pas sevré ;
 - ▷ **quantité consommée chiffrée en paquet-année PA = nombre de paquets par jour × nombre d'années de tabagisme** ; par exemple : début à 16 ans ; sevrage à 46 ans. Moyenne de consommation : 1,5 paquet par jour ; durée d'exposition : 30 ans, quantité en PA = $30 \times 1,5 = 45$ PA (à noter : 1 paquet = 20 cigarettes = 1 sachet de tabac roulé ou à pipe) ;
 - ▷ **tentatives de sevrage** : nombre, date, durée et aides éventuelles ;
 - ▷ **évaluation rapide de la dépendance** : existence complications liées au tabagisme, délai entre le réveil et la première cigarette, test de Fagerström (cf. annexe 2, p. 23) ;
- prévention systématique : on en profitera pour demander au patient s'il souhaite arrêter : si oui, débuter le sevrage ; si non, réaliser un conseil minimum : information simple sur les moyens pour arrêter, les risques liés au tabagisme sur la santé et surtout (ce qui motive le plus), les bénéfices de l'arrêt (**renforcement positif**). Objectif : sevrage total et durable.

♦ **2. Alcool** : thème trop souvent négligé ou volontairement occulté par crainte de déranger ou de culpabiliser le patient. Certaines questions simples permettent de préciser la consommation d'alcool et le niveau de dépendance :

• **quantité consommée** et type d'alcool :

les premières questions à poser sont : « Consommez-vous de l'alcool ? » ; si oui : « Régulièrement ? » ; si régulièrement, décrivez la consommation sur une journée type du lever au coucher (ou sur 1 semaine). Préciser les alcools consommés et les quantités.

On chiffre alors la consommation déclarée d'alcool (CDA) de deux manières :

▷ **unité d'alcool internationale (UAI) par jour ou par semaine**, c'est-à-dire le nombre de verres standard : équivalent à 10 g d'alcool pur par verre. Il existe de nombreuses équivalences qui sont valables pour tous les verres d'alcool (normalement servis) : 1 UAI = 10 g d'alcool = 10 cL de vin ou champagne titrant 12° = 25 cL de bière à 5 % ou cidre sec = 2,5 cL de whisky ou de pastis, ou digestif à 45° ;

▷ **grammes par jour ou par semaine**, soit en utilisant l'équivalence 1 UAI = 10 g, soit avec la formule suivante : **quantité en gramme d'alcool pur = quantité en mL consommée × degré d'alcool (/100) × 0,8 (densité de l'alcool)** : exemple : 1 bouteille de vin titrant 12° contenant 75 cL = $750 \times 0,12 \times 0,8 = 72$ g soit 7 UAI ;

• **degré d'alcoolodépendance** :

termes à proscrire :

▷ de nombreux mots sont à éviter pour ne pas culpabiliser le patient et passer outre le tabou : on ne parle pas d'« éthanol ou OH » mais d'alcool, pas de « buveur » mais d'usager ou de consommateur d'alcool, pas d'« alcoolique, alcoolisme, éthyisme, exogénose » mais de maladie alcoolique ou mieux, en précisant le degré de dépendance : abstinent, usager simple, usage nocif, alcoolodépendance ;

▷ questions pour évaluer la dépendance : **questionnaire Audit** de l'OMS (cf. annexe 3, p. 24) ou questions simples : « Consommez-vous de l'alcool ? » Non = abstinent. Si oui : « Consommez-vous régulièrement ou occasionnellement ? » ; déterminer si le patient est usager chronique ou usager aigu ; « Avez-vous déjà eu des préjudices liés à l'alcool (corporels, violence, conduite automobile, profession...) ? » ; si non : « Consommez-vous plus de [les seuils de l'OMS] (à énumérer) ? »

Ces questions permettent de caractériser en :

- aucun dommage et consommation inférieure aux seuils : **usage simple** ;
- aucun dommage mais consommation supérieure aux seuils : **usage à risque** ;
- dommages = **usage nocif**.

« Les dommages sont-ils répétés ou existe-t-il des symptômes de dépendance (phénomène de tolérance avec augmentation de la dose et augmentation

du temps passé pour se procurer l'alcool, phénomène de sevrage en cas de suspension ou de diminution de la dose : sueurs, tremblements, agitation, hallucinations visuelles) ? » Oui = **usage nocif avec dépendance**;

- prévention :

Objectif en prévention primaire (absence de dommages sur la santé) : **recommandations de l'OMS** :

- ▷ *abstinence totale chez la femme enceinte et l'enfant* ;
- ▷ limitation de la *consommation régulière chez l'homme* : inférieure à 21 UAI par semaine avec 1 jour d'abstinence (soit 30 g/j) ; *chez la femme* : inférieure à 14 UAI par semaine avec 1 jour d'abstinence (soit 20 g/j) ;
- ▷ *consommation occasionnelle* : inférieure à 40 g par semaine en 1 prise.

Objectifs en prévention tertiaire (dommages sur la santé) : abstinence totale et durable.

- ◆ **3. HTA** : connue ou non connue. Objectif en prévention primaire : TA < 140/90 mm Hg.
- ◆ **4. Diabète** : connu ou non connu. Objectif en prévention secondaire et tertiaire : Hb glyquée < 6,5 %.
- ◆ **5. Dyslipidémie** : connue ou non connue. Objectifs pour tous : HDLc > 0,4 g/L et LDLc d'autant plus bas qu'il existe d'autres FR cardiovasculaires.

Toxiques consommés

Souvent demandé devant une situation évocatrice (confusion, coma, troubles psychiatriques, douleurs thoraciques du sujet jeune et cocaïne) ou dans un contexte social précaire. Chiffrer les toxiques et préciser les modes de consommation (inhalation, injection...). **Ne parler de toxicomanie qu'en cas d'usage avec dépendance.**

Infections sexuellement transmissibles (IST) et vaccinations

Également demandées en contexte évocateur (mode de vie, symptômes évocateurs du type écoulement urétral, leucorrhée...).

On précisera le nombre de partenaire, les méthodes de protection.

6.1.5. Conditions de vie, environnement

- ◆ **Profession** (*curriculum laboris*), l'interrogatoire est utile pour plusieurs raisons, notamment :
 - retentissement actuel ou prévisible de la pathologie en cours sur le travail ;
 - arrêt de travail à prescrire éventuellement, ou certificat d'accident de travail ;
 - maladies professionnelles : il faut dans ce cas demander au patient d'énumérer toutes les professions effectuées, les expositions toxiques potentielles et les dates/durées de ces emplois.
- ◆ **Loisirs et animaux** : insister sur l'activité physique et le niveau de pratique, jardinage...

♦ **Géographique :**

- origine géographique;
- nationalité;
- voyages récents.

♦ **Logement :**

- lieu et type d'habitation : maison/appartement;
- nombre d'étages et ascenseur (permettent d'apprécier les besoins en aide en cas de pathologie altérant les déplacements et le retentissement de cette pathologie);
- nombre de personnes partageant le domicile.

♦ **Niveau de vie**, notamment précarité :

- chômage, faibles revenus;
- couverture sociale : régime général, CMU, AME;
- mutuelle, CMU complémentaire, ou rien;
- isolement...

♦ **Entourage** : présence, éloignement...

♦ **Aide humaine +++** : aide-ménagère, auxiliaire de vie, repas portés...

6.2. Interrogatoire orienté

6.2.1. Signes généraux (SG)

- ♦ AEG : les **3 A** asthénie, anorexie, amaigrissement.
- ♦ Fièvre, frissons et sueurs.

6.2.2. SF d'autres appareils pouvant orienter le diagnostic initial

Il est alors important, comme pour l'examen physique, de détailler les **signes positifs** c'est-à-dire la présence du signe, mais aussi les **signes négatifs**, c'est-à-dire l'absence de ce signe. Par exemple, l'absence d'antécédent chirurgical est un argument en faveur d'une appendicite.

6.3. Examen physique

Il faut éviter, dans cette partie, de parler de signes fonctionnels si cela a déjà été mentionné dans l'anamnèse orientée. Cependant, on peut inclure les SF des autres appareils en même temps que les signes physiques recherchés pour chaque partie.

6.3.1. Constantes

- ♦ **Poids, taille, calcul de l'indice de masse corporelle – IMC** (*indice de masse corporelle*) et **tour de taille** (TT, mesuré à mi-distance de la crête iliaque et des côtes inférieures) sont très importants et trop souvent oubliés. L'IMC

> 30 (voire 25, surpoids) et le TT (> **102 cm** chez l'homme, > **88 cm** chez la femme) sont des facteurs de risques cardiovasculaires.



Calcul de l'IMC en $\text{kg/m}^2 = P/T^2$ avec P en kg et T en mètre

- ♦ **PA** (pression artérielle), **FC** (fréquence cardiaque), **température**, **FR** (fréquence respiratoire), **SpO₂** (saturation en O₂) et **glycémie capillaire** souvent réalisées.
- ♦ **BU (bandelette urinaire)** fait partie de l'examen clinique : réalisée devant toute **fièvre**, tout **signe fonctionnel urinaire** ou toute **douleur abdominale**.

6.3.2. Appareil par appareil

Au mieux, orienté selon les hypothèses diagnostiques dégagées par l'interrogatoire.

Au stade d'apprentissage pour le jeune étudiant, il est plus important de s'exercer à être systématique et à faire un examen complet.

On recherche donc, appareil par appareil, les signes physiques décrits dans chaque partie. Aidez-vous de la check-list en partie 4.

6.4. Examens complémentaires déjà réalisés

Dates et résultats.

6.5. Conclusion

6.5.1. Résumé clinique

Sexe, âge, consulte ou est hospitalisé pour : résumé avec regroupement syndromique sans recopier les informations précédentes.

Montrer que l'on comprend le patient en globalité, c'est-à-dire partir de la clinique avant de parler des examens complémentaires déjà réalisés.

6.5.2. Hypothèses diagnostiques et étiologiques

Toujours argumenter chaque hypothèse avec les arguments pour et les arguments contre. Justifier logiquement de nouveau en partant de la clinique pour aller aux examens complémentaires. **Hiérarchiser** les hypothèses par probabilité et fréquence.

Le plan d'argumentation suivant est très utile et permet de raisonner logiquement : **TA FAC PD** Terrain, Antécédents, argument de Fréquence, Anamnèse, Clinique, Paraclinique, Diagnostic différentiel.

Exemple de justification d'une hypothèse :

- ♦ arguments pour :
 - terrain : tranche d'âge, sexe, facteurs de risques ;
 - antécédents ;
 - argument de fréquence ;
 - anamnèse ;
 - clinique : signes physiques ;
 - paraclinique : examens complémentaires ;
- ♦ arguments contre : diagnostic différentiel probable car présence d'atypies (les préciser).

6.5.3. Conduite à tenir (CAT)

Diagnostic

Examens complémentaires nécessaires **hiérarchisés** :

- ♦ du moins invasif au plus invasif ;
- ♦ du plus simple au plus complexe ;
- ♦ du plus urgent au moins urgent ;
- ♦ du moins cher au plus cher.

Et surtout, uniquement les examens complémentaires **utiles**, c'est-à-dire pouvant apporter une information (positive ou négative) et **modifier le devenir du patient** : décision thérapeutique, diagnostic précis.

Par exemple, une radiographie de l'abdomen sans préparation devant toute douleur abdominale isolée est inutile car l'information apportée ne changera pas le devenir du patient.

Thérapeutique

Proposer un traitement, et systématiquement y associer la **surveillance** du patient : mesure des constantes, examen clinique, dosages de médicaments, biologie. Le but de cette surveillance est double mais essentiel, il s'agit d'évaluer :

- ♦ la **tolérance** du traitement : recherche d'effets secondaires, surdosage ;
- ♦ l'**efficacité** : vérifier que le traitement fonctionne.

On surveille un traitement de la même manière qu'on raisonne, c'est-à-dire en commençant par une surveillance clinique (anamnèse et examen physique) puis par les examens complémentaires si nécessaires.

7 Suivi du patient au cours de l'hospitalisation : évolution

Pendant l'hospitalisation du patient, il est important de noter dans le dossier médical des mots d'évolution. Sur le plan formel, on note la date et le nom du ou des médecins qui ont participé à ce suivi.

Les informations suivantes doivent figurer :

- ◆ **efficacité du traitement** : évolution des symptômes et signes physiques présents initialement, correction des anomalies des examens complémentaires;
- ◆ **tolérance** : présence ou non d'effets indésirables, complications;
- ◆ recherche de **complications de décubitus** chez les sujets alités (très important mais, évidemment, à prévenir par matelas adaptés, mise au fauteuil, entretien articulaire et musculaire, alimentation protéique) (*cf. annexe 1, p. 22*);
- ◆ résultat des examens complémentaires diagnostiques : inutile de tout recopier. Mentionner seulement les informations (positives ou négatives) qui font avancer le diagnostic;
- ◆ consentement écrit ou oral avant la réalisation de certains examens complémentaires ou certains traitements;
- ◆ discussion autour du patient lorsque le diagnostic est difficile à établir, en cas de maladie grave, lorsqu'une information a été donnée au patient ou à sa famille, nouvelles informations obtenues par des tiers...

Annexe 1 : Complications de décubitus

11 complications	Pathologies
Cutanées	Escarre
Cardiovasculaires	Désadaptation cardiaque à l'orthostatisme et à l'effort : hypotension orthostatique, fatigue, tachycardie, dyspnée MTE : TVP-EP Œdèmes
Osseuses	Déminéralisation avec fractures pathologiques. Lithiases urinaires
Articulaires	Raideur, ankylose, rétractions tendineuses
Musculaires	Amyotrophie Chute
Neurologiques	Compressions de nerfs périphériques = syndrome canalaire
Respiratoires	Encombrement bronchique Atelectasie Pneumopathies
Digestives	Anorexie, dénutrition = infections Constipation, fécalome RGO et œsophagite, fausses routes, inhalation
Urinaires	Infections urinaires RAU surtout si fécalome Lithiases
Psychologiques	Anxiété Dépression Syndrome de régression psychomotrice Confusion
Nosocomiales	Infections nosocomiales

Annexe 2 : Questionnaire de Fagerström sur la dépendance nicotinique

1. Combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?	• moins de 5 minutes • 6 à 30 min • 31 à 60 min • après 60 min	3 2 1 0
2. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où cela est interdit (cinéma, bibliothèque, par exemple) ?	• oui • non	1 0
3. Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable ?	• la première • une autre	1 0
4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne ?	• 10 ou moins • 11 à 20 • 21 à 30 • 31 ou plus	0 1 2 3
5. Fumez-vous de façon plus rapprochée dans la première heure après le réveil que pendant le reste de la journée ?	• oui • non	1 0
6. Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit ?	• oui • non	1 0
Total :		

Résultats :

- 0 à 2 : pas de dépendance
- 3 ou 4 : dépendance faible
- 5 ou 6 : dépendance moyenne
- 7 ou 8 : dépendance forte
- 9 ou 10 : dépendance très forte

Annexe 3 : Questionnaire OMS « AUDIT » pour l'évaluation de la dépendance à l'alcool : 10 questions

Questions/Points	0 pt	1 pt	2 pts	3 pts	4 pts
Quelle est la fréquence de votre consommation d'alcool ?	Jamais	≤ 1/mois	2 à 4/mois	2 à 3/sem	≥ 4/sem
Combien de verres contenant de l'alcool consommez-vous un jour typique où vous buvez ?	1 ou 2	3 ou 4	5 ou 6	7 ou 8	≥ 10
Avec quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d'une occasion particulière ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous constaté que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire, une fois que vous aviez commencé ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque
Au cours de l'année écoulée, combien de fois votre consommation d'alcool vous a-t-elle empêché de faire ce qui était normalement attendu de vous ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu besoin d'un premier verre pour pouvoir démarrer, après avoir beaucoup bu la veille ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou des remords après avoir bu ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu ?	Jamais	< 1/mois	≥ 1/mois	≥ 1/sem	Tous les jours ou presque



Questions/Points	0 pt	1 pt	2 pts	3 pts	4 pts
Avez-vous été blessé ou quelqu'un d'autre a-t-il été blessé parce que vous aviez bu ?	Jamais	Oui mais pas au cours de l'année écoulée	Oui au cours de l'année		
Un parent, un ami, un médecin ou un autre soignant s'est-il inquiété de votre consommation d'alcool ou a-t-il suggéré que vous la réduisiez ?	Jamais	Oui mais pas au cours de l'année écoulée	Oui au cours de l'année		

Résultats en additionnant :

- 0 à 8 : pas de dépendance
- 9 à 12 : consommation nocive
- ≥ 13 : dépendance à l'alcool

Annexe 4 : Sevrage « non programmé » en alcool

Un malade hospitalisé et qui fait un mésusage d'alcool risque de développer un **syndrome de sevrage en alcool**. La gravité peut être extrêmement variable, c'est pourquoi il ne faut pas passer à côté. **Toute consommation d'alcool régulière** au-delà des seuils de l'OMS doit être prise en compte et mener à des **mesures de prévention** (évaluation initiale et surveillance selon 2 échelles CIWA-AR et échelle de Cushman, hydratation et si besoin mesures médicamenteuses). De plus, d'autres complications liées aux **carences en vitamines** doivent être prévenues par apport de vitamine B1.

Le syndrome de sevrage peut survenir de **quelques heures à 7 jours** après l'arrêt de l'alcool mais peut survenir également avec une simple diminution de consommation. Des antécédents de sevrages sévères, éventuellement compliqués de **convulsions** ou **delirium tremens**, une grossesse en cours, des comorbidités, des difficultés psychologiques, d'autres addictions sont à prendre en compte.

Le syndrome de sevrage en alcool est défini selon le DSM par la présence d'au moins 2 symptômes parmi les suivants :

- ♦ hyperactivité autonome : FC > 100, sudation, HTA;
- ♦ tremblements des mains;
- ♦ insomnie, cauchemars;
- ♦ nausées-vomissements;
- ♦ hallucinations (souvent visuelles, araignées... ou auditives, tactiles);
- ♦ anxiété, irritabilité;
- ♦ confusion;
- ♦ agitation psychomotrice;
- ♦ crise comitiale type grand mal.

Cependant, ces symptômes peuvent être expliqués par d'**autres causes** fréquemment associées à l'alcoolisme (dysnatrémie, autres médicaments, traumatisme crânien...). Il faudra les éliminer avant de parler de syndrome de sevrage.

L'intensité du syndrome dépend de plusieurs facteurs : quantité consommée, ancienneté de mésusage, brutalité du sevrage, antécédents de sevrages sévères...

Les symptômes les plus graves se produisent plus tardivement, en plusieurs jours et un sevrage sévère expose au risque de **convulsions** et **delirium tremens**. L'évolution peut être grave et mortelle.

Le **delirium tremens** se définit par la survenue des symptômes suivants :

- ♦ confusion, hallucinations non critiquées et menaçantes;
- ♦ agitation intense;
- ♦ tremblements des extrémités, membres et corps entier;
- ♦ troubles centraux : fièvre, pression artérielle instable, déshydratation, tachycardie sévère.

Ceci implique une prévention et une surveillance durable. Celle-ci est réalisée par 2 scores permettant de définir la sévérité du syndrome de sevrage et la prise en charge.

Score de Cushman : addition de points selon 7 paramètres cliniques. Sevrage **minime** si score 0 à 7, sevrage **modéré** si 8 à 14, sevrage **sévère** si 15 à 21.

	0	1	2	3
Pouls*	< 80	81–100	101–120	> 120
PA systolique**	< 135	136–145	146–155	> 155
Fréquence respiratoire*	< 16	16–25	26–35	> 35
Tremblement	0	De la main en extension	Tout le membre supérieur	Généralisé
Sueur*	0	Paumes	Paumes et front	Profuse
Agitation	0	Discrète	Généralisée, contrôlable	Généralisée, incontrôlable
Troubles sensoriels	0	Géné par le bruit, la lumière, prurit	Hallucination critiquée	Hallucination non critiquée

* Critère valables en l'absence de fièvre (température < 38 °C).

** Critères valables entre 31 et 50 ans. Ajouter 10 mm Hg au-delà de 50 ans.

Score CIWA-AR : addition de points selon les questions.

Le sevrage est :

- ♦ léger si < 10;
- ♦ modéré si 10 à 20;
- ♦ sévère si > 20.

Nausées et vomissements : Demander : « Avez-vous des nausées ? Avez-vous vomi ? » Observer.

0 Ni nausée, ni vomissement

4 Nausées intermittentes avec haut-le-cœur

7 Nausées constantes, fréquents haut-le-cœur et vomissements

Tremblements : Évaluer bras tendus et doigts en face de l'examineur. Observer.

0 Pas de tremblement

1 Invisibles, mais sentis du bout des doigts

4 Modérés, lorsque les bras sont tendus

7 Sévères, même avec les bras non tendus

Sueurs paroxystiques : Observer.

- 0 Pas de sueur visible
- 1 Sueur à peine perceptible. Paumes moites
- 4 Front perlé de sueur
- 7 Sueurs profuses

Anxiété : Demander : « Vous sentez-vous nerveux ? » Observer.

- 0 Pas d'anxiété. Détendu
- 1 Légèrement anxieux
- 4 Modérément anxieux, sur ses gardes, on devine une anxiété
- 7 Équivalent d'état de panique aiguë, tel que l'on peut le voir dans les états délirants sévères ou les réactions schizophréniques aiguës

Agitation : Observer.

- 0 Activité normale
- 1 Activité légèrement accrue par rapport à la normale
- 4 S'agite et gigote, modérément
- 7 Marche de long en large pendant l'évaluation, ou s'agite violemment

Troubles des perceptions tactiles : Demander : « Avez-vous des démangeaisons, des sensations de fourmillements, de brûlures ? Des engourdissements ? Ou avez-vous l'impression que des insectes grouillent sur ou sous votre peau ? »

- 0 Aucun trouble de ce registre
- 1 Très peu de démangeaisons, de sensations de fourmillements, de brûlures ou d'engourdissements
- 2 Peu de troubles cités ci-dessus
- 3 Troubles cités ci-dessus modérés
- 4 Hallucinations modérées
- 5 Hallucinations sévères
- 6 Hallucinations extrêmement sévères
- 7 Hallucinations continues

Troubles des perceptions auditives : Demander : « Êtes-vous plus sensibles aux sons qui vous entourent ? Sont-ils stridents ? Vous font-ils peur ? Entendez-vous un son qui vous perturbe ? Entendez-vous des choses que vous savez ne pas être réellement là ? »

- 0 Aucun son troublant
- 1 Sons très peu stridents ou effrayants
- 2 Sons peu stridents ou effrayants
- 3 Sons modérément stridents ou effrayants
- 4 Hallucinations modérées
- 5 Hallucinations sévères
- 6 Hallucinations extrêmement sévères
- 7 Hallucinations continues

Troubles des perceptions visuelles : Demander : « La lumière vous paraît-elle trop vive ? Sa couleur est-elle différente ? Vous fait-elle mal aux yeux ? Voyez-vous des choses qui vous perturbent ? Voyez-vous des choses que vous savez ne pas être réellement là ? »

- 0 Aucun trouble de ce registre
- 1 Troubles très peu sensibles
- 2 Peu sensibles
- 3 Modérément sensibles
- 4 Hallucinations modérées
- 5 Hallucinations sévères
- 6 Hallucinations extrêmement sévères
- 7 Hallucinations continues

Céphalées : Demander : « Avez-vous des sensations anormales au niveau de la tête ? Avez-vous l'impression d'avoir la tête serrée dans un étau ? » Ne pas évaluer les étourdissements, ni les sensations de tête vide. S'attacher plutôt à la sévérité.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 0 Céphalée absente | 4 Modérément sévère |
| 1 Très légère | 5 Sévère |
| 2 Légère | 6 Très sévère |
| 3 Modérée | 7 Extrêmement sévère |

Troubles de l'orientation : Demander : « Quel jour sommes-nous ? Où êtes-vous ? Qui suis-je ? »

- 0 Orienté(e) et peut faire des additions en série
- 1 Ne peut faire des additions en série ou est incertain(e) de la date
- 2 Erreur sur la date de moins de 2 jours
- 3 Erreur sur la date de plus de 2 jours
- 4 Désorienté(e) dans l'espace et/ou par rapport aux personnes

Un guide d'apprentissage pratique de l'examen clinique, à utiliser pendant toute la durée des études de médecine, de kinésithérapie ou d'ostéopathie.

VALIDÉ
par un collège
de relecteurs
universitaires

UN OUVRAGE COMPLET...

Ce guide, validé par un collège d'enseignants universitaires, propose une sémiologie raisonnée, fondée sur les preuves et conforme à la pratique actuelle.

Une première partie développe le **vocabulaire de base de la sémiologie médicale** et la **méthodologie de l'examen clinique**.

La deuxième partie détaille la **sémiologie clinique par appareils**, en précisant pour chaque examen les signes fonctionnels et physiques. Les 20 chapitres sont largement **illustrés de photographies en couleurs** pour une meilleure compréhension des observations et des tests médicaux à effectuer lors de l'examen.

La troisième partie aborde la sémiologie biologique et les examens complémentaires, ainsi que les grands principes de sémiologie médicale.

... ADAPTÉ AUX BESOINS DES ÉTUDIANTS

Élaboré pour accompagner les étudiants **depuis le début de leur cursus jusqu'à l'usage hospitalier**, cet outil couvre tous les besoins :

- ▶ la recherche rigoureuse et systématique des signes physiques en DFGSM 2 et 3 grâce à la **check-list** en fin d'ouvrage, pour ne rien oublier lors de l'examen ;
- ▶ la **sémiologie orientée**, abordée lors de l'apprentissage des pathologies pendant l'externat ;
- ▶ une utilisation simplifiée grâce à **l'index des termes médicaux**, avec leur étymologie.

Le langage utilisé est clair et adapté aux débutants. **Les moyens mnémotechniques** et les astuces pratiques facilitent l'assimilation des informations.

L'APPLICATION SMARTPHONE OFFRTE !

Elle vous permet de rechercher rapidement au lit du malade les informations pratiques mais aussi de parcourir l'essentiel de la sémiologie médicale.

PUBLICS : ÉTUDIANTS EN MÉDECINE • KINÉSITHÉRAPEUTES • OSTÉOPATHES

L'auteur, Baptiste Coustet, est médecin spécialiste et passionné de sémiologie.

ISBN : 978-2-311-66089-0



www.vuibert.fr